

Fecha Última Actualización: 24-03-2022 0:12:13

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Susana Orietta Meza Varas

Rut : 14.474.328-8

N° Archivo : 2116513

N° Epicrisis
298219

Edad : 47a 5m 10d

Fecha Nacto: 14/10/1974

Sexo : Femenino

Dirección : Av Profe Julio Chavez 12634 P. Raul Del

Comuna : La Pintana

Teléfono : 9 5621 7446

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 02/03/2022 05:21

Días Estadía: 22

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básic

Fecha Egreso : 24/03/2022 00:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

-Hiperglicemia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 02/03/22

FI UTIM: 02/03/22

FI UPC: 04/03/22

FI HM: 23.03.22

Antecedentes:

MÉDICOS: DM2IR, HTA, LMA riesgo intermedio (completó consolidación en enero 2022), hemorragias retinales en cuadro cuadrantes con pérdida agudeza visual secundario a trombocitopenia severa

QUIRÚRGICOS: cirugía menisco derecho, 2CCA

FÁRMACOS: insulina NPH, metformina, losartan, jardiance

ALERGIAS: no

HÁBITOS: tabaquismo 2 cig/día hace 31 años IPA 3.1, suspendido 2021 OH social ocasional Drogas no

GO: G3A0P3

INMUNIZACIONES: 2 dosis COVID19

HOSPITALIZACIONES RECIENTES: Enero-Febrero 2021 neutropenia febril

SOCIAL: autovalente, vive con pareja e hijos

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes mencionados, consulta por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por vómitos biliosos y fiebre cuantificada en 37.8°C. Sin diarrea ni transgresión alimentaria. Al interrogatorio dirigido refiere historia de larga data de fatiga y decaimiento. Ingresa en regulares condiciones generales, PA 113/95 PAM 101, taquicardica 156 afebril 36.6°C, sat 97% ambiental. Al examen físico se describe deshidratada, sin otros hallazgos que consignar.

Lab: lipemia +++, Hb 11.2 GB160.700, 97% blastos, plaq 28.000 INR 1.56 TTPK 22 pH 7.15 PCO2 23 bic 7.9// ELP 133/4.4/101// láctico 9.9 lipasa 1453 A. úrico 11.7 crea 1.13 NU 17.9 ELP 138/3.52/110 PCR 95 INR 1.49, PPHH normales, albúmina 3.4 ca 12.2 P 2.4 pH 7.33 PCO2 36 bic 19.2, cuerpos cetónicos +++, PCR Sars Cov2 (-), HGT 552, AngioTAC TAP: pancreatitis aguda intersticial edematosa. Leve esplenomegalia. Vesícula biliar y vías biliares sin alteraciones tomográficas. Se reanima con 4.000 cc cristaloides, se inicia BIC insulina y carga KCl, Evaluada por hematología, se diagnostica recaída, se indica hidratación, alopurinol y citorreducción con hidroxurea.

Ingresa a UTIM para continuar con estudio y tratamiento.

Fecha Epicrisis : 24/03/2022 00:12

Página 1 de 4

DIAGNÓSTICOS INGRESO UTIM

- 1.Hiperleucitosis
- 2.Recaída LMA
- 3.Pancreatitis aguda BISAP 1
- 4.Secundario a hipertrigliceridemia
- 5.CAD
- 6.AKI KDIGO I prerrenal

EVOLUCION EN UTIM

HDN: autosostenida, láctico en rango, volemicación en contexto de recaída LMA, CAD y PA. 04/03/22 evoluciona con requerimiento de NAD hasta 0.2 ug/kg/min asociado a peak febril.

Respiratorio: inicialmente sin conflicto. Dado contexto séptico, se realiza manejo avanzado de vía aérea.

Infeccioso: Ingresa en contexto de CAD, pancreatitis y recaída LMA, parámetros inflamatorios elevados pero sin foco, inicialmente sin ATB. El 03/03/22 evoluciona subfebril hasta 37.7°C por lo que se hemocultiva y se inicia Vancomicina/Imipenem.

Oncológico: LMA desde agosto/2021. Citometría de flujo al debut: 42 % de blastos indiferenciados, CD 56, CD 33 y CD 123 positivos. Biología molecular: NPM1 positivo FLT3 ITD positivo. Inducción 3+7 09/09, evoluciona con aplasia esperada, con refractariedad plaquetaria

Mielograma + EMR 12/10 negativo para blastos

1ra consolidación 20/10/21, 2da consolidación 22/11/21, 3ra consolidación 12/01/22

Ingresa por cuadro gastrointestinal destacando leucocitosis hasta 160.000 con 97% de blastos en periferia con lo que se diagnostica recaída, evaluada por Hematología, se indica prevención síndrome de lisis tumoral, citorreducción con hidroxurea, evitar transfusión de GR por riesgo leucostasis y transfusión de plaquetas 2 veces al día. Una vez compensada de CAD/pancreatitis evaluar segunda línea QMT.

Metabólico: Se inició manejo con volemicación, BIC insulina, que se mantiene al momento de traslado a UPC.

Renal: ingresa con AKI KDIGO I prerrenal. Se mantiene volemicación y seguimiento de función renal y ELP.

DIAGNÓSTICO INGRESO UPC

- 1.Shock en estudio, obs séptico vs hipovolémico
 - a.Pancultivo pendiente
- 2.Pancreatitis aguda BISAP 1
 - a.APACHE 20 puntos
 - b.Hipertrigliceridemia moderada
- 3.CAD moderada resuelta
- 4.Leucemia Mieloide Aguda
 - a.Recaída leucemia mieloide aguda
 - b.Hiperleucocitosis
 - c.Bicitopenia
 - d.Hipercalcemia leve a moderada

EVOLUCIÓN EN UCI

Hemodinámico: Shock hipovolémico por 3 espacio por PA, recibe cristaloides y albúmina, NAD, requiere múltiples TX de GR y plaquetas.

15/03 manejo depletivo por balances hídricos predominantemente positivos, presenta posteriormente requerimientos de vasopresores en relación a uso de sedación y por peaks febriles. Suspende NAD el 19/03, y el 20/03 se reinician VDO.

Respiratorio: extubación el 20/03, con salida a O2 por naricera, sin requerir ventilación no invasiva.

Infeccioso: Recibe imipenem + vancomicina durante 8 días hasta el 11/03. 14/03 presenta elevación de PPII + peaks subfebriles desde el 13.03, se pancultiva, TAC TAP sin foco infeccioso o colección, el 14/03 presenta nuevo peak febril se reinicia imipenem y vancomicina, se aísla E. coli MS en UC, se desescala a ceftriaxona, evoluciona con PPII estacionarios y con peaks febriles, se pancultiva nuevamente el 17/03, y se realiza cambio de CVC y cultivo de su punta el 18/03, el 19/03 se decide cambio a amikacina.

Gastrointestinal: pancreatitis aguda, secundario a hipertrigliceridemia, se realiza manejo medico con buena evolucion, sin complicaciones en imagenes. Alteración de PPHH ,obs secundario a ATB con mejoría de estas al suspender.

Renal/Medio Interno: Durante hospitalización presenta AKI etiología multifactorial, asociado a hipercalcemia severa y cuadro inflamatorio sistémico, evoluciona con mejoría de función renal, retornando a su basal y con adecuada diuresis, presenta varios episodios de hipokalemia las cuales son corregidas con cargas de este electrolito.

Metabólico/Nutrición: CAD que se maneja con BIC de insulina, logrando criterios de resolución el 04/03, se mantiene con requerimientos de insulina EV dado cuadro inflamatorio sistémico.

Hemato-oncológico: recaída de LMA con hiperleucocitosis y riesgo de leucostasis, manejo citorreductor con hidroxiurea, evoluciona con parcial respuesta al manejo dado disminución parcial de hiperleucocitosis, con múltiples requerimientos transfusionales dado falla medular por quimioterapéuticos y uso de citorreductor, en seguimiento por especialidad quien indica que dado recaída temprana de leucemia, se trata de paciente de mal pronóstico vital. Al ingreso presenta hipercalcemia, con PTH baja por lo que se sospecha hipercalcemia maligna relacionado con neoplasia hematológica, manejada con bifosfonato con adecuada respuesta, alopurinol para prevención de síndrome de lisis tumoral.

Neurológico: inicialmente con delirium, posterior a extubación evoluciona sin delirium, sin compromiso de conciencia, el 22/03 en la mañana paciente en sopor profundo, con midriasis bilateral, GCS 4/15, se realiza TAC de cerebro s/c, que evidencia hematoma subdural agudo derecho, asociado a hematoma subdural interhemisférico y desviación de la línea media hacia contralateral. Evaluado por neurocirugía, quien ante por condición actual de paciente, enfermedad de base asociado a mal pronóstico de esta, desestima manejo quirúrgico

En contexto de LMA, con recaída temprana, con mal pronóstico, que además presenta hemorragia intracraneana, paciente con mal pronóstico vital a corto plazo por lo que se decide limitar esfuerzo terapéutico.

Se decide traslado a unidad Básica para cuidados de fin de vida.

Fallece a las el 23.03.22 a las 23:30 hrs

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

1. Hematoma subdural agudo derecho
2. Shock Hipovolémico resuelto
Pancreatitis aguda
3. Pancreatitis aguda resuelta BISAP 2
APACHE 26 puntos
Etiología: Hipertrigliceridemia severa
4. Cetoacidosis diabética moderada resuelta
5. Leucemia Mieloide Aguda
Recaída LMA
Hiperleucocitosis
Bicitopenia
6. Hipercalcemia severa resuelta
obs maligna
7. AKI KDIGO I resuelta
obs Prerenal
8. Alteración pruebas de función hepática resuelta

Fecha Epicrisis : 24/03/2022 00:12

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 24-03-2022 0:12:13

Página 4 de 4

Patrón colestásico
obs DILI
9. Infección de vías urinarias en tratamiento
E. coli multisensible

Diagnóstico de Egreso

Leucemia Mieloide aguda -
Choque séptico -
Hematoma subdural - Hematoma Subdural Derecho

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente evoluciona en malas condiciones y fallece a las 23:30 el 23.03.22

Plan Post Alta

NA

Indicaciones

Tipo de Reposo : Na

Régimen Alimentario : Na

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Jaime Andres Granada Castaño
Becado/Residente



Rene Aedo Benavente
Médico Tratante (Staff)